



**FACULDADE**  
**CIÊNCIAS MÉDICAS**  
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



*FUNÇÃO · MENTE · CORPO · REDE*

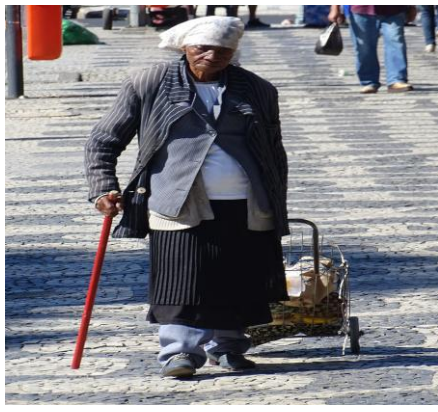
Saúde do Idoso

# Avaliação Geriátrica Ampla (AGA)

A avaliação multidimensional completa da pessoa idosa

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA          | Avaliação Geriátrica Ampla — visão completa (todos os domínios)                         |
| AUTOR         | Prof. Dr. Igor Morais — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia) |
| DISCIPLINA    | Saúde do Idoso — 9º período                                                             |
| INSTITUIÇÃO   | FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais                                   |
| CARGA HORÁRIA | 35 minutos (panorâmica)                                                                 |
| DATA / VERSÃO | 2026 · v2.0                                                                             |

# “Doutor, é só fraqueza da idade” — quantos diagnósticos a consulta tradicional perde?



## Sra. M., 82 anos

Multimorbidade: HAS, DM2, artrose.

Veio “porque está mais devagar e cansada”.

PA, glicemia e exames: “dentro do esperado”.

## O que a queixa esconde — e a AGA revela:



Parou de cozinhar e pegar ônibus (FUNÇÃO)



Esquecimentos e humor rebaixado (MENTE)



Perdeu 4 kg; não escuta bem (CORPO)



Mora só; filha distante (REDE)

*A mesma paciente atravessa os quatro pilares da AGA nesta aula.*

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

# Ao final, você conduz uma AGA completa pelos quatro pilares



### Justificar

1

a AGA multidimensional e a centralidade da funcionalidade nos desfechos.



### FUNÇÃO

2

aplicar Katz/Barthel, Lawton e mobilidade/quedas (TUG/SPPB).



### MENTE

3

rastrear cognição (MEEM) e humor (GDS-15), vendo o atípico.



### CORPO

4

nutrição (MAN), sensorial, continência, sono, boca e polifarmácia.



### REDE + síntese

5

APGAR/Zarit; integrar no diagnóstico funcional global e escolher o cenário.

*Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por  $\geq 1$  questão no quiz final.*

## A AGA completa em quatro pilares — e depois, síntese e cenário



*Vou retomar este mapa a cada virada de pilar.*

# A geriatria deslocou o foco da doença para a funcionalidade



## O Brasil envelhece rápido — a demanda por avaliação multidimensional cresce junto

**32,1 mi**

pessoas com 60+ anos

**15,6%**

da população (era 10,8% em 2010)

**+56%**

de idosos em 12 anos

**80**

idosos p/ 100 crianças

População 60+ (milhões) — Censos IBGE



Fonte: IBGE, Censo 2022.



### Implicação para a prática

Mais idosos com multimorbidade no consultório, na enfermaria e no hospital de transição — sem AGA, os problemas funcionais passam despercebidos, como na Sra. M.

### 3 • CONCEITO-CHAVE

# Funcionalidade é o desfecho que importa — a AGA mede a reserva e a fragilidade

*Senescência → Senilidade → Fragilidade → Incapacidade*



**Robusto**

Envelhecimento fisiológico; reserva preservada



**Em risco**

Reserva reduzida — janela de prevenção



**Frágil**

Declínio funcional estabelecido; alta vulnerabilidade

**A AGA avalia os sistemas funcionais principais — os 4 pilares de hoje:**



**FUNÇÃO**



**MENTE**



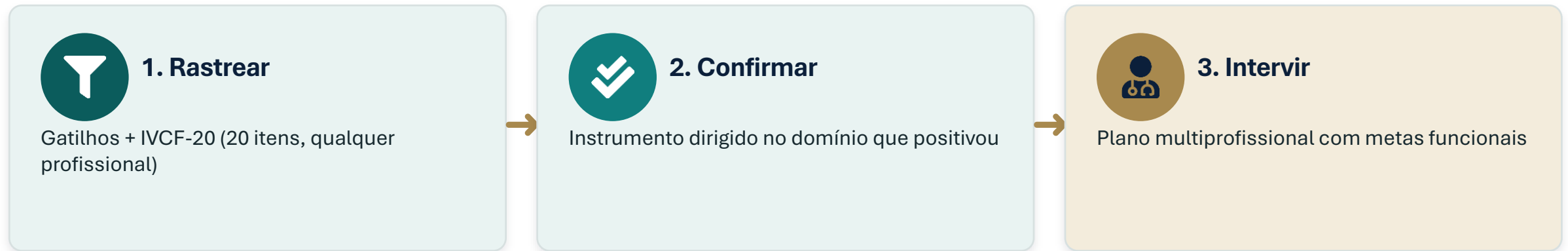
**CORPO**



**REDE**

#### 4 • COMO A AGA FUNCIONA

## Rastrear → confirmar → intervir: triagem rápida e aprofundamento dirigido



### Gatilhos de alerta que indicam a AGA (red flags):



Perda funcional recente



Emagrecimento



Polifarmácia (≥5)



Quedas / internação / delirium



Isolamento / morar só



Queixa de memória

*IVCF-20 — rastreio brasileiro de fragilidade, validado.<sup>3</sup>*



# A AGA cobre todos estes domínios — agrupados em quatro pilares



CORPO é o pilar mais largo — concentra os domínios “silenciosos” que mais escapam.

## FUNÇÃO 1 — ABVD: meça o autocuidado com Katz (e gradue com Barthel)



### Índice de Katz

6 atividades · independente × dependente (0–6).

0

Totalmente independente

1–5

Dependência parcial

6

Totalmente dependente

### Alternativas

**Barthel (0–100):** gradua a intensidade — 100 independente; <20 dependência total. Ideal para medir evolução na reabilitação.



### Bandeira clínica

**Avalie o DESEMPENHO real** (o que faz), não a habilidade declarada. Perda de ABVD = dependência maior, perde-se depois das AIVD.

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Katz 1963; Mahoney & Barthel 1965.

## FUNÇÃO 2 — AIVD: o declínio aparece primeiro; rastreie com Lawton



### Escala de Lawton-Brody

9 atividades instrumentais; cada item 1–3 (escore 9–27).

25–27

Independente

10–24

Parcial

9

Totalmente dependente

### Alternativas

**Pfeffer:** respondido pelo informante; sensível ao declínio ligado à demência ( $\geq 6$  = comprometido).



### Bandeira clínica

**Pergunte “o que ele deixou de fazer?”** Perder telefone, compras, finanças, transporte ou medicação é o sinal de alarme mais precoce.

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Lawton & Brody 1969; Pfeffer 1982.

## FUNÇÃO 3 — mobilidade e quedas: testes objetivos dizem quem vai cair



### TUG (instrumento de escolha)

Levantar, andar 3 m, voltar e sentar.  
Tempos altos ( $\sim \geq 12-20$  s) = maior risco.



### SPPB

Equilíbrio + marcha + sentar-levantar 5×;  
escore de desempenho físico.



### Tinetti (POMA)

Equilíbrio e marcha; menor escore, maior  
risco.



Pedro R. Simões · CC BY 2.0



**Queda não é “normal da idade”.** Toda queda no último ano é red flag: investigue causas, fármacos e ambiente. A queda prediz nova queda, fratura e perda de independência.

## MENTE 1 — cognição: rastreie com o MEEM, sempre ajustando à escolaridade



### Miniexame do Estado Mental

Rastreio; interpretar por escolaridade (não há corte único).

**Escolar.**

Ajustar o ponto de corte

**Normal**

P/ a escolaridade

**Alterado**

P/ a escolaridade

### Alternativas

**MoCA** (mais sensível ao comprometimento leve), fluência verbal, desenho do relógio, lista de palavras (CERAD).



### Bandeira clínica

**Cognição × humor:** depressão pode simular demência (pseudodemência). Sempre rastreie o humor junto.

*Fonte: instrumento AGA-SBGG; Folstein 1975; Brucki et al. 2003 (normas BR); MoCA.*

## MENTE 2 — humor: a depressão se disfarça; rastreie com a EGD/Yesavage-15



### Escala de Depressão Geriátrica (15)

Rastreio prático de depressão no idoso.

≤ 5

Normal

≥ 7

Provável depressão

≥ 11

Moderada a grave



Foto: "Old man alone" · jaocampo · CC0 (Wikimedia Commons)

### Alternativas

**EGD-5** (triagem ultrarrápida); PHQ-9; Cornell (na demência).



### Bandeira clínica

**Apresentação atípica:** queixas somáticas, insônia, anorexia e anedonia — sem "tristeza" explícita. Não atribua a "é da idade".

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Yesavage 1982; validação BR Almeida & Almeida 1999.

## CORPO 1 — nutrição: rastreie com a MAN, apoiada por peso e panturrilha



### Mini Avaliação Nutricional (MAN)

Triagem + avaliação global.

$\geq 24$

Nutrido

17–23,5

Risco

$< 17$

Desnutrido

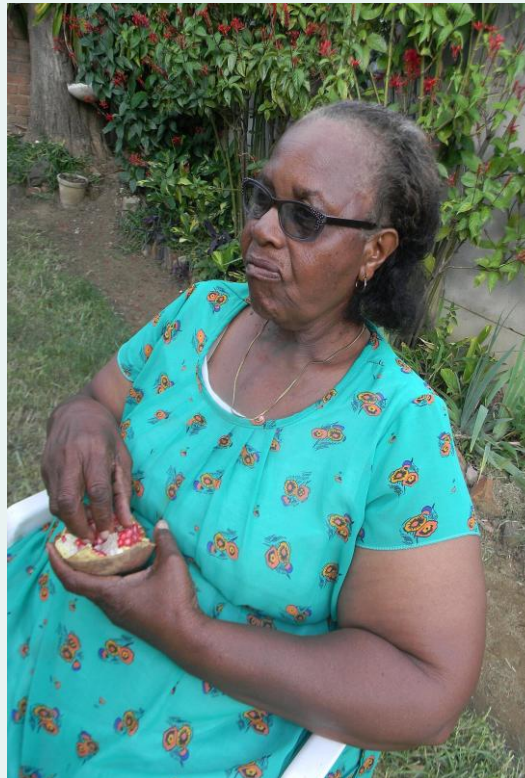


Foto: Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

### Alternativas

**Apoio objetivo:** perda  $\geq 5\%$  do peso em 3–6 m; IMC (corte mais alto no idoso); circunferência da panturrilha  $< 31$  cm (massa muscular).



### Bandeira clínica

**Desnutrição  $\neq$  magreza** (pode haver IMC normal/alto). Diferencie de sarcopenia (força/massa $\downarrow$ ; reversível com exercício + proteína).

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Guigoz/Vellas (MNA).

## CORPO 2 — visão e audição: déficits sensoriais imitam demência e isolam



### Visão

**Triagem:** tabela de Snellen; pergunta “tem dificuldade para ler/enxergar?”.

Corrigir refração e catarata melhora função, humor e quedas.



### Audição

**Triagem:** teste do sussurro; pergunta “tem dificuldade para conversar em grupo?”.

Perda auditiva associa-se a declínio cognitivo, depressão e isolamento.



**Bandeira:** déficit sensorial não corrigido simula demência no MEEM e agrava a fragilidade. Sempre cheque óculos e aparelho auditivo antes de rotular cognição.



## CORPO 3 — continência, sono e saúde bucal: pergunte ativamente, pois ninguém conta



### Continência

Pergunte sobre perdas urinárias/fecais (frequência, tipo). Investigue causas reversíveis e funcionais; impacto em pele, quedas e isolamento.



### Sono

Rastreie insônia, sonolência diurna, ronco/apneia, pernas inquietas. Antes de hipnótico: higiene do sono e revisão de fármacos.



### Saúde bucal

Dentes/próteses, mastigação, xerostomia, lesões. Boca ruim → desnutrição e infecção; ligação direta com nutrição.

## CORPO 4 — polifarmácia: revise com Beers/STOPP-START e cace a cascata



### Revisão estruturada de fármacos

Polifarmácia =  $\geq 5$  medicamentos de uso contínuo.

**Beers**

Evitar no idoso

**STOPP**

Suspender inapropriados

**START**

Iniciar o que falta



Foto: Mpelletier1 · CC BY-SA 3.0 (Wikimedia)

### Alternativas

**Atenção à carga:** anticolinérgica e sedativa; risco de hipotensão, quedas,  $\downarrow$ Na,  $\uparrow$ QTc.



### Bandeira clínica

**Cascata de prescrição:** efeito adverso tratado como nova doença. Pergunte sempre “este sintoma é da doença ou do remédio?”.

Fonte: AGS Beers Criteria 2023; O'Mahony et al. STOPP/START.

## REDE — o idoso é tão forte quanto sua rede: família, cuidador e sobrecarga



### APGAR da Família

5 itens (Adaptação, Participação, Crescimento, Afeto, Resolução). >6 boa · 4–6 disfunção mod. · <3 acentuada.



### O cuidador

Vínculo (formal/informal), conflitos, capacidade. Rastrear abuso/negligência. Quem cuida do cuidador?



### Sobrecarga: Zarit

Mede a sobrecarga do cuidador. Alta → risco para idoso e cuidador; aciona rede formal de apoio.

*Fonte: instrumento AGA-SBGG; APGAR de Smilkstein 1978; Zarit 1980.*

## Os quatro pilares convergem no diagnóstico funcional global e no grau de fragilidade



### FUNÇÃO

AIVD↓ + TUG 16 s + 1 queda → declínio instrumental e risco de quedas



### MENTE

Esquecimentos + anedonia → rastrear cognição e depressão



### CORPO

-4 kg (MAN risco) + hipoacusia → risco nutricional e sensorial



### REDE

Mora só, filha distante → suporte frágil

### Diagnóstico funcional global

Idosa EM RISCO DE FRAGILIZAÇÃO: declínio instrumental, risco de quedas, risco nutricional, provável depressão e suporte frágil.

**Grau de fragilidade** — Escala Clínica de Fragilidade (1 muito ativo → 9 doente terminal) orienta metas e intensidade.

## A AGA só vale se vira plano — e o plano gera desfecho funcional

### Plano de cuidados multiprofissional



Médico: revisar fármacos, tratar humor, metas



Fisioterapia: marcha, força, quedas



Nutrição: aporte proteico-calórico



Serviço social: rede e cuidador



Fono/TO: deglutição, cognição e AVD



### Evidência (forte)

AGA hospitalar ↑ a chance de o idoso estar **vivo e no próprio domicílio** no seguimento.

**RR ~1,06 (IC95% 1,01–1,10) vivo e em casa.**

Pouca/nenhuma diferença na mortalidade (RR 1,00).

*No idoso, o desfecho que importa é funcionalidade e independência — não só sobrevida.*

Fonte: Ellis G, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017;CD006211 (29 ensaios; 13.766 participantes).

## Prevenir bem é “menos é mais” — e também não esquecer a vacinação



### Prevenção quaternária

- Evitar iatrogenia: cascata de prescrição, polifarmácia, exames sem benefício.
- Metas individualizadas pela funcionalidade e prognóstico.
- Desprescrição (Beers/STOPP-START); proporcionalidade terapêutica.



### Prevenção que se faz

- Vacinação: influenza, pneumococo, tétano, herpes-zóster, COVID-19 (conforme calendário vigente).
- Atividade física e exercício resistido (função e quedas).
- Reconhecer e referenciar precocemente o idoso em risco.

*Calendário vacinal do idoso: confira a versão vigente (PNI/Ministério da Saúde e SBIm).*

# A AGA completa é, por excelência, ambulatorial — no hospital agudo tem limites



## Ambulatório — cenário ideal

- Paciente estável: desempenho “real” mensurável
- Tempo e múltiplas consultas para a AGA completa
- Longitudinalidade: acompanha a evolução
- Foco em prevenção e manutenção da função



## Hospital agudo — limitações

- Doença aguda e delirium distorcem o desempenho
- Acamado: escalas subestimam a função basal
- Tempo curto; prioridade é estabilizar
- Risco de “rotular” dependência transitória

*Regra prática: no agudo, registre a funcionalidade BASAL (pré-internação) e reavalie após estabilizar.*

## CONVITE À EQUIPE

# Façam a AGA breve no hospital de transição: a janela perfeita

*Paciente já estabilizado + tempo de permanência + meta de alta = cenário ideal para avaliar e agir.*



### Janela ideal

Pós-fase aguda: o desempenho já reflete a capacidade real e modificável



### Tempo a favor

A permanência permite AGA completa e reavaliação seriada



### Direciona a reabilitação

Define metas funcionais objetivas para a equipe



### Planeja a alta segura

Antecipa rede, cuidador e adaptações — reduz reinternação



### Otimiza fármacos

Momento de ouro para desprescrição e ajuste de metas



### Mede resultado

Barthel/Lawton na entrada e na saída mostram o ganho



## O erro nº 1: avaliar a habilidade declarada em vez do desempenho real



### A armadilha

“A senhora toma banho sozinha?” → “Tomo.”

Mas a filha dá banho há meses.

**Katz/Barthel medem DESEMPENHO REAL, não habilidade.**



### Como evitar

- Pergunte “quem faz?” e “como foi a última vez?”
- Confirme com o informante (Pfeffer)
- Cheque sentidos antes de rotular cognição; cuidado com superproteção



**Curiosidade:** a geriatria moderna nasce nos anos 1930 com Marjory Warren, que ao reavaliar “incuráveis” e reabilitá-los provou que a avaliação funcional muda destino — a origem da AGA.

# A AGA completa cabe em quatro pilares

## FUNÇÃO · MENTE · CORPO · REDE

*avalie sempre os quatro — o que escapa quase sempre está no CORPO (sentidos, boca, sono, fármacos)*



### FUNÇÃO + MENTE

AVD (Katz/Lawton), quedas (TUG); cognição (MEEM, ajuste escolaridade) e humor (GDS-15).



### CORPO

Nutrição (MAN), visão/audição, continência, sono, boca e polifarmácia (Beers/STOPP).



### REDE + síntese

APGAR/Zarit → diagnóstico funcional global e grau de fragilidade; depois, plano.

## Teste rápido: Q1 a Q3

**Q1**

**Idosa diz “tomo banho sozinha”, mas a filha dá banho há 3 meses. Como registrar na AGA?**

A) Independente B) Dependente (desempenho real) C) Ignorar a filha D) Reavaliar em 1 ano

**Q2**

**Paciente com MEEM “baixo”, porém 2 anos de escolaridade. Conduta?**

A) Já é demência B) Interpretar o corte pela escolaridade C) Iniciar anticolinesterásico D) Ignorar

**Q3**

**Idoso sem “tristeza”, com dor difusa, insônia e anorexia. Rastreio de humor?**

A) Barthel B) MAN C) EGD/Yesavage-15 D) Katz

*Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.*

## Mais três e os comentários

**Q4.** Idoso emagrecendo, parou de cozinhar. Rastreio nutricional?

**Q5.** Tontura nova após anti-hipertensivo somado a outro fármaco. Conceito?

**Q6.** Melhor momento da AGA breve no hospital de transição?

### Gabarito comentado

**Q1 → B** — Mede-se desempenho real; “habilidade” declarada engana.

**Q2 → B** — MEEM não tem corte único: interpretar pela escolaridade.

**Q3 → C** — Depressão atípica: somatização, insônia, anorexia, anedonia.

**Q4 → MAN** — Rastreio nutricional. Barthel/Katz = funcional; MEEM = cognição.

**Q5 → Cascata** — Efeito adverso tratado como doença nova → desprescrever.

**Q6** — Estabilizado + tempo + meta de alta = avaliar e agir com impacto.

## Recapitule agora — e revise de novo nos próximos dias

### Em 30 segundos, recupere de memória:

- Os 4 pilares (FUNÇÃO·MENTE·CORPO·REDE)
- 1 instrumento de escolha por domínio + 1 corte
- 3 bandeiras clínicas que mudam conduta
- Por que a AGA breve cabe no hospital de transição



### 3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Por que o MEEM precisa ser ajustado à escolaridade?
2. Quais domínios do CORPO mais escapam — e como rastreá-los?
3. Cite 3 vantagens da AGA breve no hospital de transição.

## REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

# Referências

1. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(9):CD006211.
2. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Avaliação Geriátrica Ampla (AGA): instrumento e educação continuada.
3. Moraes EN, Carmo JA, Moraes FL, et al. Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20 (IVCF-20). Rev Saúde Pública. 2016;50:81.
4. Moraes EN, Lanna FM. Avaliação multidimensional do idoso / Modelo de funcionalidade global (Nova AGA, SBGG, 2023).
5. IBGE. Censo Demográfico 2022 — população por idade e sexo.
6. Katz S, et al. The index of ADL. JAMA. 1963;185:914-9. · Mahoney FI, Barthel DW. Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:61-5.
7. Lawton MP, Brody EM. IADL. Gerontologist. 1969;9:179-86. · Pfeffer RI, et al. J Gerontol. 1982;37:323-9.
8. Folstein MF, et al. Mini-Mental State. J Psychiatr Res. 1975;12:189-98. · Brucki SMD, et al. MEEM no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 2003;61:777-81.
9. Yesavage JA, et al. GDS. J Psychiatr Res. 1982-83;17:37-49 (validação BR: Almeida & Almeida, Arq Neuropsiquiatr 1999). · Guigoz/Vellas (MNA).
10. Smilkstein G. Family APGAR. J Fam Pract. 1978;6:1231-9. · Zarit SH, et al. Gerontologist. 1980;20:649-55. · AGS Beers Criteria 2023; O'Mahony D, et al. STOPP/START.

*Pontos de corte conforme o instrumento AGA-SBGG; calendário vacinal e validações brasileiras devem ser conferidos na versão vigente.*

## CRÉDITOS

# Créditos de imagens e nota de marca

**Fotografias** (Wikimedia Commons — licença livre, com atribuição):

- Idosa no Rio de Janeiro e idoso em asilo (Paraty, BR) — Adam Jones, Ph.D. · CC BY-SA
- Idoso com bengala — Pedro Ribeiro Simões · CC BY 2.0
- Idoso sentado sozinho — jaocampo · CC0
- Pessoa idosa se alimentando — Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
- Frasco de comprimidos — Mpelletier1 · CC BY-SA 3.0

**Ícones:** Font Awesome (licença livre). **Diagramas/gráficos:** originais desta aula.



**Marca institucional:** logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner institucional no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG em toda a aula.

# Obrigado!

A AGA completa cabe em quatro pilares: **FUNCAO · MENTE · CORPO · REDE.**

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saude do Idoso — FCMMG

FACULDADE  
CIÊNCIAS  
MÉDICAS  
É NOTA

★★★★★

**5 MÁXIMA**

NO MEC

